Validação e Teste de Usabilidade
Jornada Oncológica

Registro consolidado dos testes realizados no ambiente local — versão preliminar

Este documento reúne os registros de teste da equipe sobre a revisão final do sistema (PR 35). Os testes foram realizados no navegador, por meio do endereço http://localhost:5173/, contemplando seis cenários principais, na mesma organização do guia de testes, e um cenário complementar sobre o sigilo dos dados salvos no navegador. Quando os registros coincidem, a informação aparece uma única vez; as observações individuais estão identificadas por autor ao longo do documento.

Parte dos registros foi feita em 23/09/2026, com o sistema executado via Docker, em janela anônima do Chrome e com os pacientes de exemplo do próprio sistema. Os cenários 1 a 6 foram testados manualmente; nos cenários 3 e 4, o teste manual foi complementado por análise do código e geração de PDFs de teste, com apoio do Claude Code. Para executar o sistema via Docker, foi necessário um ajuste na configuração de instalação do front-end, proposto separadamente no PR #36.

O resultado consolidado de cada cenário considera a ressalva mais restritiva registrada. Este documento aguarda a contribuição do terceiro integrante da equipe.

Cenário	Validação	Consolidado
1	Administrador e gestão de profissionais	Validado com ressalvas
2	Ficha de Enfermagem e salvamento automático	Validado com ressalvas
3	Herança de dados entre especialidades	Validado com ressalva
4	Ficha consolidada e exportação em PDF	Validado com ressalvas
5	Consulta pública da jornada	Validado com êxito
6	Acessibilidade e responsividade	Validado com ressalva
7	Sigilo dos dados salvos no navegador	Pendência identificada

Cenário 1 - Perfil de Administrador e Gestão de Profissionais

Objetivo: validar o acesso do perfil Administrador, o cadastro e o gerenciamento de profissionais e a navegação entre perfis.

- Seleção do perfil "Administração" na tela de login; o sistema abre diretamente na Gestão de Profissionais.
- Cadastro de novo profissional pelo botão "Novo profissional", com preenchimento dos dados, e confirmação da inclusão imediata na lista.
- Teste da função de edição de profissional.
- Navegação para o "Painel Geral" e retorno à Gestão de Profissionais: o profissional cadastrado não permanece na lista.
- Acionamento da seta "Voltar" na Gestão de Profissionais: não há efeito.

- Abertura de paciente com alerta confidencial de vulnerabilidade social: o Administrador visualiza o alerta.
- Acesso com o perfil Coordenação: o menu exibe apenas "Painel Geral", "Pacientes" e "Metas de tempo".

Ana Clara: validado com ressalvas.
Felipe: validado com ressalvas (observações 1, 6 e 7).
Matheus: validado com ressalvas. (observações 14 e 15).
Resultado consolidado: Validado com ressalvas.

Cenário 2 - Preenchimento de Ficha e Salvamento com F5 (Enfermagem)

Objetivo: validar o preenchimento da ficha e a proteção contra perda de dados por meio do salvamento automático.

- Acesso ao perfil Profissional, seleção de paciente e abertura da etapa de Enfermagem.
- Preenchimento de alergia, com o campo condicional "A que e qual a reação?", e da avaliação da dor.
- Confirmação da gravação do rascunho no armazenamento do navegador.
- Atualização da página com a tecla F5, novo acesso e confirmação da permanência dos dados digitados.
- Alteração de "Alergia" para "Não": o campo condicional é ocultado e o valor é apagado.
- Finalização pelo botão "Finalizar avaliação" e geração do alerta persistente de dor intensa (Nível 2).
- Em outra especialidade, registro de texto em "Observações", retorno sem salvar e reabertura: o texto é restaurado sem aviso de rascunho.

Ana Clara: validado com ressalva de navegação (observação 4).
Felipe: validado com ressalva (observação 3).
Matheus: validado com êxito.
Resultado consolidado: Validado com ressalvas.

Cenário 3 - Herança de Dados Compartilhados (Nutrição / Medicina)

Objetivo: validar o reaproveitamento de dados já registrados por outra especialidade, reduzindo retrabalho.

- Abertura de formulário de outra especialidade (Medicina e Nutrição) da mesma paciente após o preenchimento da Enfermagem.
- Confirmação do preenchimento automático dos dados compartilhados, que aparecem bloqueados para edição, com selo de origem em texto ("↩ Enfermagem") e botão "Ignorar".
- Conferência, no código, dos campos compartilhados: a Medicina herda alergia, reação alérgica, comorbidades, tabagismo, etilismo e MMII; a Nutrição herda escolaridade, tabagismo e etilismo.
- Constatação de que a Enfermagem não possui campos de sinais vitais: os valores de pressão arterial e frequência cardíaca citados no guia de testes vêm dos dados de exemplo.

Ana Clara: validado com ressalva.
Felipe: validado com ressalva (observação 9).
Matheus: validado com ressalvas. (observações 15 e 16).
Resultado consolidado: **Validado com ressalva.**

Cenário 4 - Ficha Consolidada e Exportação em PDF

Objetivo: validar a consolidação das informações clínicas e a geração de documento único.

- Acesso à "Ficha consolidada" e verificação da identificação do paciente, data e hora de geração e blocos das especialidades preenchidas.
- Exportação do PDF, abertura do arquivo e conferência da organização e legibilidade.
- Geração de PDFs de teste com os perfis Profissional, Recepção e Administrador, usando as mesmas funções da tela.
- Verificação do responsável pela exportação, da versão, dos dados compartilhados com origem e dos alertas de divergência.
- Confirmação de que o nome do arquivo não contém o nome da paciente e de que cada exportação gera um novo arquivo.
- Confirmação de que os campos confidenciais (ideação suicida e vulnerabilidade social) não aparecem na versão da Recepção.

Ana Clara: validado com êxito.
Felipe: validado com ressalvas (observações 1, 2, 10 e 11).
Matheus: validado com ressalvas. (observações 16, 17 e 18).
Resultado consolidado: **Validado com ressalvas.**

Cenário 5 - Consulta Pública de Jornada (Paciente / Acompanhante)

Objetivo: validar a apresentação da jornada ao público geral com linguagem simples e proteção das informações clínicas.

- Acesso à consulta pública pelo link na tela de login.
- Pesquisa da paciente pelo nome, pelo CPF e pelo código.
- Verificação da linha do tempo com etapas concluídas e próximas orientações.
- Confirmação de que não são exibidos escores, alertas, observações dos profissionais nem CPF completo.

Ana Clara: validado com êxito.
Felipe: validado com êxito, com ponto para discussão (observação 1).
Matheus: validado com êxito.
Resultado consolidado: **Validado com êxito, com ponto para discussão na observação 1.**

Cenário 6 - Acessibilidade e Responsividade (Celular / Teclado)

Objetivo: validar o comportamento do sistema em diferentes tamanhos de tela e formas de navegação.

- Teste de responsividade em 360 px e 768 px, com verificação do recolhimento do menu lateral, da ausência de rolagem horizontal e da usabilidade dos botões.
- Navegação apenas pelo teclado (Tab, Enter e Espaço), incluindo login, opções Sim/Não e escala de dor.
- Verificação do foco visível durante a navegação por teclado.

- Verificação de alertas com ícones e textos, sem dependência exclusiva de cores.

Ana Clara: validado com ressalva
Felipe: validado com ressalva (observação 8).
Matheus: validado com ressalvas.
Resultado consolidado: **Validado com ressalva.**

Cenário 7 - Sigilo dos Dados Salvos no Navegador

Objetivo: verificar se os dados gravados pelo salvamento automático ficam restritos aos perfis autorizados (RF-004 / RNF-002).

- Consulta ao armazenamento do navegador (F12 > Application > Local Storage) após o preenchimento da ficha.
- Saída do sistema pelo botão "Sair" e novo acesso com o perfil Recepção.
- Verificação de que a lista de pacientes, com as respostas dos formulários e os alertas confidenciais, continua gravada e acessível no navegador.

Ana Clara: cenário não avaliado.
Felipe: pendência identificada (observação 1).
Matheus: validado com ressalvas.
Resultado consolidado: **Pendência identificada, descrita na observação 1.**

Observações identificadas durante a validação

1. Sigilo e perfis de acesso [CONFIRMAR COM A EQUIPE]: os pontos abaixo envolvem sigilo e o que cada perfil pode ver. Serão verificados com a instituição e, quando envolverem solução técnica, com a equipe de desenvolvimento. (Felipe)

- Dados gravados no navegador: o salvamento automático grava a lista de pacientes, com as respostas dos formulários e os alertas confidenciais. Os dados permanecem após "Sair" e podem ser consultados por qualquer perfil no mesmo computador (tecla F12), o que contraria o RF-004/RNF-002. Não há, na interface, opção para limpar esses dados. Opções para discussão: manter por se tratar de protótipo, registrando a decisão; apagar os dados ao fechar a aba; ou apagar os dados ao clicar em "Sair".
- Alertas confidenciais: o Administrador visualiza alertas confidenciais, como o de vulnerabilidade social, e aparentemente esse acesso é esperado. A Recepção hoje não vê nenhum alerta confidencial, mas talvez precise de algumas informações.
- Ficha consolidada: a Recepção consegue abrir a ficha consolidada e exportar o PDF com dados clínicos, como avaliação da dor, diagnóstico e comorbidades. O texto livre de "Observações" da Psicologia e do Serviço Social também aparece para esse perfil.
- Consulta pública: as informações clínicas ficam protegidas, mas qualquer pessoa que souber o nome da paciente consegue ver a jornada dela. Avaliar se a busca deve exigir mais de um dado de identificação.
- Menu da Coordenação: a Coordenação deixou de ter acesso ao menu "Profissionais", que passou a ser exclusivo do Administrador. Confirmar se a mudança foi intencional.

2. Escore ASG-PPP calculado sem dados: Com peso e altura preenchidos e o questionário ASG-PPP em branco, a ficha consolidada mostra "ASG-PPP: 0 pontos — Não há necessidade de intervenção neste momento". Uma recomendação é apresentada a partir de dado ausente, o que contraria o RF-020 e o RF-021. Sugestão: exibir "não preenchido" quando o questionário estiver em branco. (Felipe)

3. Rascunho restaurado sem aviso: Ao reabrir uma ficha com rascunho não salvo, o conteúdo volta como se fosse o registro, sem indicação de que se trata de rascunho. O

rascunho fica guardado por paciente e especialidade, e não por usuário; em computador compartilhado, o próximo profissional pode entender que a informação já foi registrada. Sugestão: exibir o aviso "Rascunho não salvo, restaurado de [data/hora]", com as opções "Continuar" e "Descartar". (Felipe)

4. Atualização da página (F5): Ao recarregar a aplicação, é necessário realizar novamente o acesso à conta, e o sistema não retorna automaticamente à aba ou etapa que estava aberta antes da atualização. Os dados já digitados permanecem salvos, sem perda das informações registradas no formulário. Esse comportamento não impediu a conclusão do teste, mas pode ser considerado oportunidade de melhoria da experiência de navegação. O mesmo comportamento ocorreu no teste de Felipe. (Ana Clara)

5. Item relacionado a "transporte pela prefeitura" [CONFIRMAR COM A EQUIPE]: Recomenda-se revisar a nomenclatura e a adequação desse fluxo ao contexto da Rede de Atenção à Saúde no Distrito Federal. Como o DF não possui prefeitura municipal, é importante verificar qual serviço, órgão ou ponto da rede seria efetivamente responsável pelo transporte sanitário ou apoio ao deslocamento do paciente. O item deve ser validado com a equipe assistencial e com o fluxo real do serviço antes de permanecer com essa denominação no sistema. Complemento (Felipe): o termo aparece na opção "Ambulância / Transporte da Prefeitura" do formulário de Enfermagem; o Serviço Social pergunta o mesmo dado com outras opções (Transporte Público, Transporte Particular, TFD), e os dois podem ser revistos em conjunto. (Ana Clara)

6. Seta "Voltar" sem efeito: Na Gestão de Profissionais, com o perfil Administrador, a seta "Voltar" não leva a nenhuma tela. (Felipe)

7. Profissionais cadastrados não permanecem na lista: O profissional cadastrado aparece na lista, mas deixa de aparecer ao trocar de tela. O comportamento já existia antes desta revisão, mas afeta a principal tela do perfil Administrador; pode ser tratado em uma issue separada. (Felipe)

8. Foco visível pouco nítido em botões azul-escuros: Nos botões "Entrar" (tela de login) e "Continuar formulário" (ficha do paciente), o contorno que indica o foco do teclado usa o mesmo tom de azul do botão e fica difícil de enxergar (RNF-007). Sugestão: usar um contorno de foco em cor contrastante e revisar os demais botões azuis. (Felipe)

9. Rótulos dos campos não ligados tecnicamente aos campos (RNF-007): em todos os formulários, o texto da pergunta aparece na tela, mas não está ligado tecnicamente ao campo de resposta. Para quem usa leitor de tela, o campo é anunciado apenas como "caixa de texto" ou "botão de opção", sem a pergunta correspondente, o que impede o preenchimento por pessoas com deficiência visual. Além disso, clicar no texto da pergunta não posiciona o cursor no campo. O comportamento já existia antes desta revisão e não afeta a navegação por teclado, que funcionou normalmente no teste. A identificação foi feita pela análise do código, sem teste com leitor de tela. Sugestão: ligar cada pergunta ao seu campo nos componentes compartilhados dos formulários, o que corrige a maior parte do sistema sem alterar o conteúdo das perguntas. (Felipe)

10. Herança limitada a campos com o mesmo nome interno: A herança funciona, mas só entre campos guardados com o mesmo nome técnico. A Nutrição, por exemplo, não herda alergia nem comorbidades, porque não tem esses campos. O guia de testes cita pressão arterial e frequência cardíaca preenchidas na Enfermagem, mas esse formulário não tem campos de sinais vitais. As oportunidades de ampliar a herança estão na análise complementar ao final deste documento. (Felipe)

11. Versão do documento fixa [CONFIRMAR COM A EQUIPE]: Todo PDF exportado traz "Versão do documento: 1.0", independentemente de quantas vezes a ficha tenha sido exportada ou alterada. É necessário definir o que "versão" deve representar, conforme o RF-018. (Felipe)

12. Data e hora de geração do PDF: O campo "Gerado em" registra o momento em que a tela da ficha foi aberta, e não o momento do clique em "Exportar PDF". Se a tela ficar aberta por algum tempo, o PDF mostra um horário anterior à exportação, diferente do horário que aparece no nome do arquivo. (Felipe)

13. Atualização automática da lista (não testado): A cada 30 segundos, a tela substitui a lista de pacientes pelos dados do servidor, que não trazem as respostas dos formulários. O comportamento é anterior a esta revisão e não foi testado nesta rodada, porque exige preparar o banco de dados. Fica registrado como pendência para um próximo teste. (Felipe)

14. **Retorno para aba diferente da inicial:** A seta “retorno”, após acessar a aba “Pacientes” e “Metas de tempo”, envia o usuário para a aba “Painel Geral”, que também acontece ao se selecionar um paciente, abrir o respectivo prontuário e clicar na seta de retorno. Acredito que seja interessante que o retorno seja para a página de origem. (Matheus)
15. **O sistema não diferencia novos cadastros:** Ao se cadastrar um profissional novo, o sistema não discrimina se já existe cadastro prévio (mesmo e-mail pode ser cadastrado duas vezes); além disso, inativar um profissional não tem uma confirmação por pop-up se a ação deve ser executada. (Matheus)
16. **O sistema somente mostra a especialidade:** Quando houve o preenchimento de uma informação, o sistema indica de qual especialidade veio a informação, mas não o nome do usuário nem a data de registro. Isso pode ser uma fonte de conflitos, por não se saber quem foi o responsável por inserir informações possivelmente divergentes, cabendo necessidade de ajuste. (Matheus)
17. **A busca devolve o primeiro paciente encontrado:** Isso pode ser um problema no que diz respeito à LGPD. O primeiro nome retornado pela API não necessariamente corresponde ao do paciente a ser estudado; nesse caso, pode-se ter acesso a informações de pessoas alheias ao caso em questão. Talvez fosse interessante filtrar por número de prontuário ou os 4 primeiros dígitos do CPF. (Matheus)
18. **O sistema não impõe um limite de tentativas:** Isso também pode ser um problema em relação à LGPD. Buscas sem limite por nomes aleatórios de vários pacientes podem gerar, em algum momento, acesso a informações e prontuários que são sigilosos e não necessariamente deveriam ser acessados. (Matheus)

Análise complementar - Aproveitamento de Dados entre Formulários

Objetivo: identificar outros campos que poderiam ser compartilhados entre formulários, reduzindo retrabalho (RF-006 / RF-009).

Foram analisados 305 campos dos 9 formulários de especialidade, do bloco de dados reaproveitados e do cadastro da Recepção. Hoje, um dado é herdado quando dois formulários o guardam com o mesmo nome interno. Esse nome é técnico e invisível para o usuário: pode ser alinhado sem alterar o texto das perguntas nem as opções de resposta. Quando as respostas são diferentes (por exemplo, "Nega" e "Não"), o sistema já tem um recurso de tradução, usado hoje na faixa de renda. O detalhamento campo a campo está registrado em documento à parte (ANALISE_HERANCA_CAMPOS.md).

Principais achados

- Cadastro da Recepção não aproveitado: data de nascimento, telefone, endereço, estado civil, cor/raça, religião, acompanhante e diagnóstico/CID já são coletados no cadastro, mas são perguntados novamente na Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Fonoaudiologia. É o maior ganho possível, com ajuste técnico em um único ponto.
- Ligações possíveis sem mudar perguntas: medicações de uso contínuo (Enfermagem e Medicina), tratamento em curso (Medicina e Fonoaudiologia), estadiamento (Medicina para Nutrição), alergia (Enfermagem para Odontologia), cirurgia prévia, suporte familiar e acompanhante (Enfermagem para Serviço Social) e via de alimentação (Fonoaudiologia e Nutrição).
- Campos já compartilhados com opções diferentes [CONFIRMAR COM A EQUIPE]: escolaridade tem 4 listas de opções diferentes em 4 formulários, e estado civil tem 3

listas, incluindo a do cadastro. A mesma informação aparece escrita de formas diferentes.

- Perguntas semelhantes que medem coisas diferentes [CONFIRMAR COM A EQUIPE]: dor (medida que muda ao longo do dia), disfagia (triagem ou avaliação especializada), atividade física, fadiga, quedas, tratamento oncológico prévio, naturalidade ou procedência, transporte e sinais vitais.

Cuidados

- Campos confidenciais (Psicologia, vulnerabilidade social, comunicação diagnóstica) nunca devem ter o mesmo nome de um campo comum, pois seriam herdados por outros formulários.
- Quando duas especialidades respondem o mesmo campo, hoje prevalece a que vem por último na ordem fixa de especialidades, e não a resposta mais recente. Com mais campos compartilhados, é preciso definir essa regra [CONFIRMAR COM A EQUIPE].
- Nos campos de botões (Sim/Não etc.), um valor herdado que não esteja entre as opções não aparece marcado; toda ligação com tradução deve converter para uma opção existente.

Prioridade sugerida

1. Herdar os dados do cadastro da Recepção: alto ganho, baixo risco.
2. Ligar os campos de texto livre equivalentes: ganho médio, baixo risco.
3. Ligar os campos que exigem tradução de respostas: ganho médio, exige testar cada tradução.
4. Padronizar as listas de opções e decidir os casos de perguntas semelhantes: depende da equipe.

Achado lateral: no bloco "Procedência", ao trocar a opção "Outro" por outra, os valores escondidos de estado e cidade não são apagados, contrariando a regra do projeto de limpar campos ocultos. A correção é pequena. (Felipe)

Validação e Teste de Usabilidade
Jornada Oncológica

Registro consolidado dos testes automatizados e de interface — complemento à revisão final (PR 35)

Este documento reúne os registros de teste da interface de usuário (Frontend), complemen-tando os testes anteriores. Os testes foram realizados simulando os fluxos de renderização de componentes e a comunicação interna de estados do navegador.

Cenário	Validação	Consolidado
8	Autenticação, Criação de Profissional e Gestão de Sessão	Pendência identificada
9	Consistência visual dos Componentes Compartilhados (Serviço Social)	Validado com ressalvas
10	Integridade dos dados exibidos na Ficha do Paciente	Validado com ressalvas

Cenário 8 - Autenticação, Criação de Profissional e Gestão de Ses-são

Objetivo: validar se a criação de um usuário (médico) reflete corretamente em seu painel após o login.

- Acesso à gestão de profissionais pelo Administrador, e cadastro de um novo perfil.
- Deslogar e realizar o login com as novas credenciais.
- **Resultado:** A interface exibe sempre o mesmo profissional padrão (ex: "Dr. Rafael Costa"), ignorando as credenciais digitadas. Até no proprio codigo está escrito que isso é uma pendencia e que está funcionando como no prototipo, mas só pra deixar registrado.

(observação 12).

Cenário 9 - Consistência visual dos Componentes Compartilhados (Serviço Social)

Objetivo: verificar se os agrupamentos de caixas de seleção (checkboxes) se comportam de forma padronizada.

- Simulação de renderização do formulário de Serviço Social.
- Avaliação de como os botões de seleção múltipla interpretam comandos de alinhamento visual.
- **Resultado:** O formulário tenta forçar um alinhamento (direção) que o componente visual não está preparado para entender, o que pode causar desalinhamento dos itens na tela dependendo do tamanho do monitor.

Automação (QA): Validado com ressalvas (observação 13).

Cenário 10 - Integridade dos dados exibidos na Ficha do Paciente

Objetivo: garantir que a ficha consolidada e a linha do tempo não exibam "buracos"de infor-mação.

- Renderização dos dados de exemplo (Mock) injetados na estrutura visual da Jornada.
- **Resultado:** Alguns rótulos exigidos pela tela (como Contato de Emergência, Origem e Data de Atendimento) não estão sendo alimentados pelos dados base, resultando na ausência dessas informações na interface.

Automação (QA): Validado com ressalvas.

Observações identificadas durante a validação

12. Ausência de Contexto Real de Sessão (Login): A quebra no fluxo de "Criar Profissional → Logar → Atender"relatada não é um erro de conexão, mas uma limitação atual do protótipo. O sistema baseia o nome exibido no topo da tela em uma regra estática vinculada apenas ao "tipo"de usuário, sem possuir uma "memória global"que lembre exatamente qual e-mail e nome foram digitados na tela de login. *(Recomendação: Implementar Contexto de Sessão Global para viabilizar testes realistas de múltiplos profissionais).*

13. Inconsistência de alinhamento no Serviço Social: O componente de múltipla escolha (Checkbox) desse formulário está recebendo comandos visuais incompatíveis com a sua estrutura. Isso não quebra o sistema ou impede o preenchimento, mas em tablets menores (como relatado no Cenário 6) pode tornar a lista de opções confusa, desalinhada ou com sobreposição de textos, dificultando a leitura rápida.